

Etablissement

Médecin responsable

PROTOCOLE DE SOINS INFIRMIERS D'URGENCE — ARTICLE R.4311-7 CSP

Dyspnée / Désaturation – Oxygénothérapie

Oxygène titré selon la clinique et une cible de SpO2, avec appel au 15 sans délai en cas de détresse.

Indications

- Dyspnée aiguë, cyanose, polypnée, tirage ou difficulté à parler.
- SpO2 basse ou chute significative par rapport à la valeur habituelle.
- Hypoxémie suspectée en attendant l'équipe médicale/SAMU.
- Toujours interpréter la SpO2 avec les signes cliniques.

Vérifications préalables

- Installer demi-assis si toléré ; libérer les voies aériennes.
- Mesurer SpO2, FR, FC, TA, conscience et température.
- Rechercher douleur thoracique, fausse route, œdème, fièvre ou encombrement.
- Identifier BPCO/risque hypercapnique et cible habituelle.

Recommandations / IMPORTANT

- Appeler le 15 immédiatement si détresse ; l'oxygène ne doit pas retarder l'alerte.
- Cible habituelle : SpO2 94–98 %.
- BPCO ou risque d'hypercapnie : cible 88–92 %, sauf consigne médicale différente.
- Ne pas laisser seul ; bronchodilatateur uniquement s'il est prescrit.

Intervention IDE

- Détresse sévère sans risque hypercapnique : masque à réservoir 15 L/min en attendant le 15.
- Situation non critique : lunettes 1–4 L/min ; cible 94–98 %.
- Risque hypercapnique : lunettes 1–2 L/min pour une cible de SpO2 à 88–92 %.
- Réévaluer toutes les 5 min et suivre les consignes du SAMU.

Surveillance et traçabilité

- Tracer heure, SpO2 initiale, cible, dispositif, débit/FiO2 et réponse.
- Surveiller conscience, FR, tirage, cyanose, parole et douleur thoracique.
- Contrôler tolérance du masque/lunettes et sécurité du matériel.
- Tracer appel, interlocuteur et consignes.

Alerte immédiate

- Appel 15 : cyanose, épuisement, silence auscultatoire, douleur thoracique, fausse route ou conscience altérée.
- Rappeler si cible non atteinte, besoin croissant en O2 ou aggravation.
- Avis médical pour toute dyspnée nouvelle même non grave.

Mention de sécurité

L'oxygène est un médicament : fixer une cible, surveiller et titrer. Une SpO2 rassurante n'exclut pas une détresse clinique ; protéger les sources d'oxygène de toute flamme ou corps gras. Compte rendu IDE écrit, daté et signé au dossier.

Fait à :

Le : / /

Signature et cachet du médecin :